Droits du patient et devoirs du professionnel

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Cours et application

Dignité et égalité

La maladie ou la dépendance ne fait pas disparaître la dignité. Préserver intimité, respect, accès aux soins et absence de discrimination. Adapter langage, installation et aide aux besoins réels, sans infantiliser. Le patient participe aux décisions qui concernent sa santé.

Information

Informer dans son champ de compétence sur les soins proposés, leur utilité, leurs modalités, les risques pertinents, les alternatives et les conséquences d'un refus. Vérifier la compréhension avec des mots accessibles. L'information n'est pas la simple remise d'une feuille : elle implique un échange. L'article L1111-2 précise notamment la preuve de l'information en cas de litige.

Consentement et refus

Le consentement doit être libre et éclairé et peut être retiré. Il se recherche tout au long des soins. Ne pas présenter tous les actes chirurgicaux ou anesthésiques comme exigeant universellement un formulaire légal de consentement : les exigences écrites dépendent des actes et des textes applicables. Face à un refus, rechercher les raisons, informer, alerter le médecin selon la situation, maintenir l'accompagnement et tracer les faits.

Volonté et proches

La personne de confiance aide et témoigne des souhaits lorsque la personne ne peut plus les exprimer. Elle ne reçoit pas automatiquement un accès général au dossier. La personne à prévenir a un rôle distinct. Une mesure de protection juridique n'efface pas la participation du patient : examiner ses capacités et la portée du jugement, plutôt que supposer qu'un tuteur décide toujours à sa place.

Secret professionnel

Protéger ce qui est confié, observé ou appris dans la prise en charge. Un partage ne répond pas à la curiosité : il doit respecter le cadre légal et porter sur les informations nécessaires. Un proche n'a pas un accès automatique aux résultats. Les dérogations et signalements répondent à des conditions précises ; ne pas les résumer par une autorisation générale de tout révéler.

Application et traçabilité

Un patient refuse un pansement car il anticipe une douleur : écouter, évaluer la douleur, expliquer les possibilités, rechercher un accord et coordonner si le refus persiste. Tracer heure, propos pertinents, information donnée, professionnels avertis et suite. « Pas écrit, pas fait » est un rappel pédagogique de l'importance de la traçabilité, pas une règle universelle annulant tout autre moyen de preuve.

Information et décision partagée

Le droit à l'information permet à la personne de comprendre ce qui lui arrive et de participer aux décisions. Il faut distinguer information médicale, information sur le déroulement pratique d'un soin et accompagnement de la compréhension. Chaque professionnel intervient dans son champ de compétence ; une question dépassant ce champ est relayée au professionnel concerné.

Une information utile précise la finalité de l'acte, ses modalités, les bénéfices attendus, les risques pertinents, les alternatives et les conséquences possibles d'un refus. L'urgence peut modifier les possibilités de l'échange, mais ne transforme pas l'information en formalité inutile. Un langage adapté et le recours aux moyens de communication nécessaires contribuent à l'effectivité du droit.

La compréhension ne se déduit pas d'un simple acquiescement. Inviter la personne à expliquer avec ses mots ce qu'elle a compris, puis corriger les malentendus. Fatigue, douleur, émotion, déficit sensoriel ou difficulté linguistique peuvent gêner la réception. Il peut être nécessaire de répéter à un moment plus favorable.

Dans le cas pédagogique d'un patient inquiet avant un pansement, l'infirmier peut expliquer le déroulement et les mesures proposées contre la douleur. Il doit aussi écouter ce que le patient craint précisément. Le but est une décision réellement comprise, et non l'obtention d'un oui par pression.

Consentement refus et situations particulières

Le consentement est un processus lié à une personne, un acte et un contexte. Il doit être recherché avant le soin puis vérifié si le contexte ou la volonté change. Une absence de protestation ne doit pas être utilisée comme preuve automatique d'un consentement lorsque la personne ne comprend pas ou ne peut pas communiquer.

Un refus appelle une évaluation : quel soin est refusé, pourquoi, avec quelle compréhension et dans quelle urgence ? Écouter sans jugement, préciser les conséquences, rechercher une alternative acceptable et coordonner avec le médecin. Respecter un refus n'équivaut pas à abandonner l'accompagnement, la surveillance ou le soulagement.

Lorsqu'une personne ne peut plus exprimer sa volonté, rechercher les éléments prévus par le cadre légal et les souhaits déjà exprimés. La personne de confiance témoigne de cette volonté ; elle n'est pas propriétaire de la décision ni titulaire d'un accès illimité aux informations. L'urgence ou l'impossibilité fait l'objet de dispositions particulières.

Pour un mineur ou une personne faisant l'objet d'une mesure de protection, il faut examiner les règles propres à la situation. Associer la personne et rechercher son expression autant que possible. Ne pas assimiler minorité, tutelle ou difficulté de communication à une absence totale de volonté. Les exceptions relatives au secret et à certains soins ne se généralisent pas à tous les actes.

Vie privée secret et traçabilité

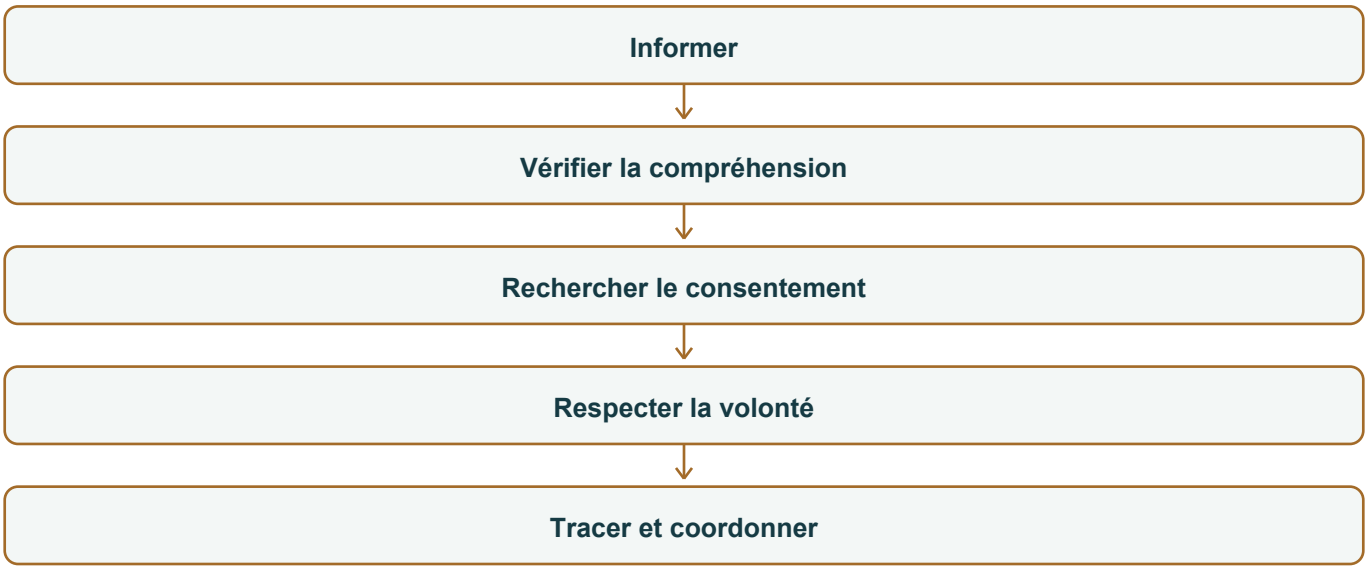
Le secret protège la confiance nécessaire aux soins. Il concerne les informations confiées mais aussi celles observées ou déduites pendant l’exercice. Les écrits, échanges oraux, écrans, photographies et transmissions numériques doivent être protégés. Une discussion professionnelle ne doit pas être entendue par des personnes non concernées.

Le partage d’informations doit répondre à la prise en charge et aux conditions légales applicables, notamment selon l’appartenance ou non à une même équipe de soins. Sélectionner ce qui est nécessaire à la mission du destinataire. La participation d’un professionnel ne lui donne pas systématiquement besoin de toutes les informations du dossier.

Personne à prévenir, aidant et personne de confiance sont des rôles distincts. Demander qui a été désigné et pour quel rôle. Un fils seulement enregistré comme personne à prévenir ne peut pas exiger tous les résultats au seul motif de sa parenté. L’équipe doit expliquer le cadre sans rompre la relation.

La traçabilité décrit les faits utiles, les informations délivrées, les décisions et leurs suites. Elle doit être datée, attribuable, compréhensible et respectueuse. Ne pas transformer une hypothèse en fait établi, ni écrire une appréciation dévalorisante. En cas de difficulté, tracer les démarches et transmissions effectivement réalisées.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Un proche est-il automatiquement personne de confiance ? Non.

Un consentement peut-il être retiré ? Oui.

Le secret interdit-il tout échange nécessaire aux soins ? Non : il impose un cadre et une nécessité.

Sources et portée

UE A2 RESUMER COURS DROIT DU PATIENT Karsenti.docx

Ressource Moodle correspondante

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185255

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34302